

Brain & Mind

Q&A

고가의 알츠하이머병 항체 치료제,
실손보험 적용 어디까지 되나?



고가의 알츠하이머병 항체 치료제, 실손보험 적용 어디까지 되나?

들어가며

알츠하이머병의 근본적 질병 조절 치료제(DMT)인 ‘레카네맵(상품명 레캠비)’이 임상 현장에 본격적으로 도입되면서 치매 진료 패러다임이 급변하고 있다. 증상 완화에 그쳤던 기존 치료제와 달리, 질병 진행을 약 27% 지연시킨다는 점에서 환자와 의료진 모두의 기대가 크다.

그러나 연간 수천만 원에 달하는 고액의 비급여 비용은 임상 현장의 가장 큰 허들이다. 환자들은 진료실에서 “실손보험 처리가 되느냐?”라는 질문을 가장 먼저 한다. 이번 호에서는 레카네맵의 실손보험 적용 여부와 민간 보험사의 최신 대응 동향을 그리고 약관 상 핵심 체크리스트를 Q&A로 정리해 보았다.

Q1. 레카네맵(레캠비)은 현재 건강보험 급여 적용을 받나?, 환자가 부담해야 하는 대략적인 비용은 어느 정도인가?

현재 레카네맵은 전액 비급여 품목이다. 정부에서 비용 대비 효과성 및 건강보험 재정 지속 가능성 등을 종합적으로 고려하고 있으나, 단기간 내에 전면 급여화가 되기는 현실적으로 어렵다.

환자가 부담해야 하는 총 비용은 약제비에만 국한되지 않아 진료실에서의 사전 안내가 필수적이다.

- **약제비:** 18개월(총 36회 투여) 기준 환자의 체중에 따라 약 3,000만 원~4,000만 원이 소요된다.
- **부대 비용:** 약물 투여 전 아밀로이드 침착을 확인하기 위한 아밀로이드 PET 검사(약 100~150만 원), 그리고 투약 과정에서 발생할 수 있는 주요 부작용인 ‘아밀로이드 관련 영상 이상(ARIA)’을 모니터링하기 위한 주기적인 뇌 MRI 검사 비용 등이 모두 비급여로 추가된다.

결과적으로 초기 진단부터 18개월 치료 완료까지 환자가 직접 부담해야 하는 총 의료비는 약 4,000만 원~5,000만 원에 육박한다.

Q2. 환자가 기존에 가입해 둔 일반 ‘실손의료보험(실비)’으로 레카네맙 치료비를 보상받을 수 있나?

결론부터 말씀드리면, “대부분 보상받기 어렵거나, 보상받더라도 극히 일부에 그친다”가 냉정한 현실이다. 환자가 가입한 실손보험의 ‘가입 시기(세대별 구분)’와 ‘질병 분류 코드’에 따라 보상 여부가 완전히 갈리기 때문이다.

1) 질병 코드의 한계(F코드 vs. G코드)

알츠하이머병은 한국표준질병사인분류(KCD) 상 ‘알츠하이머병에서의 치매(F00)’와 ‘알츠하이머병(G30)’으로 이중 분류가 가능하다.

- 2016년 1월 이전 가입자(1~2세대 일부): 과거 실손보험 약관은 정신과질환 및 행동 장애(F04~F99)를 전면 면책(보상 제외)했다. 비록 의뢰진이 G30(신경과 코드)으로 처방하더라도, 보험사는 임상적 실질이 ‘치매(F코드)’에 해당한다고 보아 지급을 거절하거나 분쟁을 일으킬 소지가 매우 높다.
- 2016년 1월 이후 가입자(3~4세대 및 2세대 일부): 개정 약관에 따라 F00~F03(치매) 질환 중 ‘국민건강보험법상 요양급여(급여)’에 해당하는 의료비는 보상하도록 변경되었다. 하지만 레카네맙은 ‘법정비급여’이므로, 이 개정 조항의 혜택을 받지 못하고 여전히 보상 대상에서 제외된다.

2) 통원 한도의 한계

설령 약관 상 비급여 보상이 가능한 특약이나 예외 조항이 있다 하더라도, 실손보험의 ‘통원 의료비 한도’라는 높은 벽에 부딪힌다. 레카네맙은 2주에 한 번씩 통원하여 정맥 주사로 투여받는 외래 중심 치료다. 일반적인 실손보험의 외래 통원 한도는 회당 20만 원~30만 원에 불과하다. 회당 100만 원이 훌쩍 넘는 레카네맙의 비용을 감당하기에는 턱없이 부족하다. 일부에서 입원 치료 형식으로 진행하여 처방 한도(연간 5,000만 원 등)를 늘리려는 시도가 있으나, 단순 주사제 투여 목적의 ‘의학적 필요성이 낮은 입원’에 대해 최근 보험사가 심사를 극도로 엄격히 하여 부지급하는 사례가 급증하고 있어 이 또한 리스크가 매우 크다.

Q3. 그렇다면 최근 보험업계에서 출시하고 있는 ‘레캬비 보험’, ‘치매 표적 약물 치료비 특약’은 무엇이며, 주요 보험사별 실제 보장 범위(약제비 vs. 검사비)와 부담액, 월 보험료는 어느 정도인가?

실손의료보험이 고가의 비급여 신약을 보장하지 못하는 공백이 발생하자, 민간 보험사들은 이를 겨냥해 정책형 ‘치매 표적 약물 허가 치료비 특약’ 상품을 대거 출시했다. 최근에는 단순히 약제비만 보장하는 것을 넘어, 투약 과정에 필수적인 검사비(뇌 MRI 등)까지 특별 담보로 결합하는 구조로 진화하고 있다.

■ 보장 범위의 핵심 쟁점: 약물 치료비 vs. 검사비 공백

임상 현장에서 간과하기 쉬운 부분 중 하나는 바로 ‘모니터링 검사 비용’이다. 레카네맙 투여 환자는 ARIA(아밀로이드 관련 영상 이상) 부작용 관찰을 위해 18개월간 최소 4~5회 이상의 비급여 뇌 MRI 촬영을 해야 하며, 투약 전 아밀로이드 침착 확인을 위한 PET 검사도 필수적이다. 이 검사비만 수백만 원에 달한다.

보험사명	대표 상품/특약명	보장 한도 및 담보 범위	검사비(MRI/PET) 포함 여부 및 특징
KB손해보험	KB 골든라이프케어 간병보험 (표적치매약물치료비 특약)	연간 최대 3,000만 원 (연간 재지급형 구조)	• 검사비 포함(ARIA 모니터링 뇌 MRI 검사비 특약 탑재) • 경도인지 장애(MCI) 진단비 강화 및 레카네맙 맞춤 설계
삼성화재	마이헬스 파트너 (치매 표적약물치료비 특약)	최대 2,500만 원 ~ 3,000만 원 (최초 1회 지급형 중심)	• 약제비 중심(일부 종합검진 연계형 특약 선택 시 지원) • 장기요양등급 판정 시 재가/시설급여 지원 특약과 시너지
흥국화재	흥쿠르트 치매간병보험 (장기치매 표적약물 특약)	최대 3,000만 원 (일시금 형태)	• 약제비만 가능(검사비 별도 보장 불가) • 가입 문턱을 낮춘 유병자형(간편 심사) 라인업에 강점
교보생명	(무)교보치매케어보험 (표적치매약물치료비 특약)	최대 2,000만 원 ~ 2,500만 원 (주계약 연계형)	• 약제비만 가능(진단비/약제비 정액 지급) • 종신/정기보험 형태 유지, 중증 치매 시 생활자금 연계

- 약물 치료비만 보장하는 상품(흥국화재, 교보생명 등): 식약처 허가 표적 약물의 ‘직접 처방 및 조제 약제비’에 대해서만 정액 보험금을 지급하므로, 주기적인 MRI 검사비나 진단 PET 검사비는 환자가 온전히 따로 부담해야 한다.
- 검사비까지 포괄 지원하는 상품(KB손해보험 등): 레카네맙 치료 프로세스에 맞춰 ‘치매 관리 MRI 검사비 특약’을 별도 부가할 수 있도록 설계되었다. 이 경우 약제비 정액 수령 외에도 비급여 부작용 모니터링 검사비를 추가로 청구할 수 있어 환자의 부담이 한층 더 경감된다.

■ 보험료 구성 및 지급 방식의 차이점

1. 가정비형 특약 설계(월 2만 원~3만 원대): 손해보험사들은 주계약을 최소화하고 표적 치매 약물 특약 위주로 가입할 경우, 50대 기준 월 2만 원대라는 합리적인 비용으로 치료비를 준비할 수 있도록 설계했다.
2. 유병자형 상품의 보험료 상승: 60대 이상이거나 당뇨병·고혈압 등 기왕력이 있는 환자는 간편심사형 상품을 이용해야 하므로, 일반 건강체 대비 보험료가 약 20~30% 할증되어 월 4만 원~6만 원대 수준으로 형성된다.
3. 연간 재지급형의 중요성: 18개월간 지속 투여해야 하는 레카네맙 특성 상, 최초 1회 지급 후 소멸하는 상품보다 연도가 바뀌면 한도가 복원되어 재지급되는 구조(KB손보 등)가 훨씬 유리하다.

Q4. 표적 치료 특약 가입 시 반드시 확인해야 할 약관 상 지급 조건과 제한사항은 무엇인가?

표적 치매 약물 허가 치료비 특약은 고액의 정액 보험금을 지급하는 만큼, 보험사의 심사 기준이 매우 까다롭다. 단순히 ‘치매 진단’을 받았다거나 ‘약물을 처방’ 받았다고 해서 무조건 지급되지 않으며, 아밀로이드 베타 양성 확인, 특정 CDR 점수, 전문의 처방 등 약관상 명시된 필수 요건을 완벽히 충족해야 한다. 다음은 의사들이 진료실에서 환자에게 설명하거나 서류를 구비할 때 도움이 되는 ‘약관 심사 핵심 체크리스트(10대 요건)’이다.

분류	핵심 확인 항목	약관 상 세부 인정 기준 및 임상적 주의사항
핵심 지급 3대 조건 (미충족 시 지급 불가)	치료 단계 및 임상치매척도 (CDR)	- 초기 단계만 인정: 임상치매척도 CDR 0.5(경도인지 장애) 또는 CDR 1 (경증 알츠하이머 치매) 단계의 환자만 보장 대상입니다. - 중등도 이상(CDR 2~3)으로 진행된 상태에서 치료를 시작하면 보상에서 제외됩니다.
	아밀로이드 베타 검사 양성 증빙	- 병리적 원인 확인 필수: 단순 인지기능 검사 수치만으로는 부지급됩니다. - 반드시 아밀로이드 PET 스캔 또는 뇌척수액(CSF) 검사를 통해 '아밀로이드 베타 단백질 축적 양성'이 확인된 결과지가 동반되어야 합니다.
	식약처 허가 및 전문의 직접 처방	진료과 제한: 식품의약품안전처에서 허가된 표적 치료제(레카네맵 등)여야 하며, 신경과 또는 정신건강의학과 전문의가 직접 치료 목적으로 처방·투약해야 인정됩니다.
계약 구조 및 제한사항 (환자 실무담약 결정 요인)	최초 투약 횟수 기준 조건	상품별 조건 상이: 일부 보험사 상품의 경우, 표적 치료제를 최소 7회 이상 지속 투여한 시점부터 비로소 보험금 지급 청구 자격이 발생하는 조건이 붙어 있으므로 선제적 확인이 필요합니다.
	지정 병원 제한 유무	의료기관 자격 확인: 모든 요양기관이 아닌, 대학병원, 대형 종합병원, 또는 보험사가 약관으로 지정한 특정 거점 의료기관에서 처방·투약받은 경우에만 한정하여 보장하는 상품이 있습니다.
	한도 유형 및 지급 방식	지속성 확인: 보장 한도가 '최초 1회 한(소멸형)'인지, 연도가 바뀌면 한도가 살아나는 '연간 1회 재지급형'인지에 따라 18개월 장기 투약 시 환자의 최종 실무담약이 천차만별로 달라집니다.
	비급여 인정 범위	약제 외 범위: 식약처 허가 약제비 외에, 투약 전 필수 진단 검사비(PET)나 투약 중 부작용 모니터링 검사비(비급여 뇌 MR)까지 정액 또는 일부 보장 범위에 포함되는 지 구별해야 합니다.
	진단명 및 질병코드 일치	이중 코드 확인: 진단단명과 한국표준질병사인분류(KCD) 코드가 약관과 정확히 일치해야 합니다(예: G30 알츠하이머병 코드 및 F00 알츠하이머 치매 코드의 보상 범위 매칭 확인).
	일상생활장해 (ADL) 연계 조건	가입 시기별 독소 조항: 2025년 기준 일부 상품 및 구형 치매 간병보험 특약의 경우, 표적약물 처방 외에도 '일상생활장해(ADL) 2개 항목 이상 제한'이라는 무거운 중증도 조건이 연동되어 있을 수 있으므로 주의를 요합니다.
	갱신형 구조 및 보험료 변동	장기 유지 비용: 표적치료 특약은 대부분 갱신형 담보로 구성되어 있습니다. 가입 초기에는 월 2~3만 원대로 저렴해 보이지만, 연령 증가 및 손해를 상승에 따라 추후 보험료가 가파르게 인상될 수 있음을 고지해야 합니다.

Q5. 임상 현장에서 의사가 환자에게 레카네맵 처방을 권유하거나 상담할 때, 보험과 관련해서 주의해야 할 점은 무엇인가?

환자와의 신뢰 관계를 유지하고 추후 발생할 수 있는 분쟁이나 민원을 방지하기 위해 다음 세 가지 사항을 반드시 숙지하고 설명해야 한다.

1) “보험으로 다 해결된다”는 확답은 절대 금물

환자의 보험 가입 시기와 개별 특약 범위에 따라 보상 여부가 완전히 다르다. 특히 가입한 상품이 ‘약제비만 지원’하는지, ‘검사비도 일부 포함’하는지 확인하지 않고 안내했다가 추후 MRI 검사비 청구 시 분쟁이 유발될 수 있으므로, 반드시 환자 본인이 보험 증권을 확인하도록 해야 한다.

2) 정확한 진단 기준과 적응증 준수 및 서류 증빙

레카네맵은 알츠하이머병으로 인한 경도인지 장애(MCI) 또는 초기 치매 환자에게만 적응증이 있다. 보험사는 고액 보험금 지급 전 아밀로이드 PET 결과지, MMSE/CDR 점수 등 객관적 서류를 정밀 심사하므로 의학적 기준을 철저히 준수하여 기록해야 한다.

3) ARIA 부작용 모니터링 검사비 사전 안내

앞서 언급한 바와 같이 주기적인 비급여 MRI 촬영 비용이 별도로 누적된다는 점을 치료 시작 전 환자와 보호자에게 명확히 고지하여 예산 수립에 차질이 없도록 해야 한다.

Q6. 향후 항체 치료제의 보험 환경은 어떻게 변화할 것으로 전망하는가?

학과와 임상 현장에서는 치료 불평등 해소와 사회적 간병 비용 절감을 위해 레카네맵의 신속한 건강보험 급여화 또는 미국·일본 식 조건부 급여 도입을 강력히 촉구하고 있다.

정부 급여화 전까지는 민간 보험 시장의 ‘표적 치매 치료비 특약’과 ‘부작용 검사비 지원 담보’가 의료 공백을 메우는 핵심 보완재 역할을 할 것이며, 향후 제약사 환자 지원 프로그램(PAP)과의 연계 여부도 주요 변수가 될 것이다.

요약 및 맺음말

레카네맵은 알츠하이머 치료의 새 지평을 열었으나 고액의 비급여 장벽이 존재한다. 일반 실손보험으로는 보상이 불가능하거나 제한적이며, 현재로서는 민간 보험사의 전용 정액 특약이 실질적인 대안이다.

특히 상품에 따라 ‘약물 치료비만 보장’하는지, 혹은 KB손해보험처럼 ARIA 모니터링을 위한 ‘비급여 뇌 MRI 검사비까지 커버’하는지 보장 범위의 외연을 명확히 구별해야 진료실에서의 혼선을 막을 수 있다. 또한 약관 상의 핵심 3대 조건(초기 단계, 아밀로이드 양성 증빙, 전문의 처방) 및 7회 투약 조건이나 지정 병원 제한 구조를 선제적으로 환자에게 안내하는 프로세스가 확립되어야 한다. 의료진이 이러한 차이점과 체크리스트를 명확히 숙지하고 환자 상담에 활용한다면, 치료 연속성을 보장하고 환자의 처방 수용률을 극대화하는 데 큰 도움이 될 것이다.

References

1. 김여진 (한림대 강동성심병원 신경과 교수), “레카네맵 도입을 통한 한국 치매 관리 패러다임 전환”, 대한신경과학회지(JKNA), 2025.
2. 금융감독원 및 손해보험협회, “세대별 실손의료보험 표준약관 변경 및 정신질환/비급여 보장 범위 안내”, 2016~24.
3. 국내 주요 보험사(KB손해보험, 삼성화재, 흥국화재, 교보생명 등) 상품 공시실, “표적 치매 약물 허가 치료비 특약 약관 및 보장 범위·한도 비교”, 2025~26.
4. 디앤시아뉴스, “레카네맵, 허가 이후 커진 급여 논쟁 및 해외 공보험(미국·일본) 적용 동향”, 2026.